**BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN**

**PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG**

# QUY TRÌNH CHĂM SÓC BỆNH DÍNH THẮNG LƯỠI

Mã đề xuất CS-TMH-04; bản trình thẩm định 14/10/2026. Chưa ban hành. Biên soạn/thẩm định/phê duyệt: ……

Áp dụng chăm sóc điều dưỡng theo bệnh, gồm nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá. Kỹ thuật xâm lấn phải có quy trình riêng theo QĐ3023, chỉ định và người đủ phạm vi/năng lực; bộ này không cho phép điều dưỡng tự chẩn đoán hoặc quyết định điều trị.

ICD: Q38.1

## 1. Nhận định

Xác nhận hai định danh, lý do đến khám, khởi phát, bệnh nền, thuốc/dị ứng; đánh giá ABCDE, sinh hiệu, đau, ăn/nuốt, dịch vào-ra và nguy cơ té ngã theo tình trạng. Báo ngay khi khó thở, thở rít, tím, giảm ý thức, chảy máu nhiều hoặc dấu giảm tưới máu. Cận lâm sàng theo bác sĩ.

- Hỏi tiền sử: có bệnh tim mạch, máu không đông không ? bé có bú khó, uống sặc, khó phát âm không?

Đánh giá vận động lưỡi, bú/ăn, nuốt, tăng trưởng và nhu cầu hỗ trợ. Bác sĩ xác định dính thắng lưỡi có ảnh hưởng chức năng; không mặc định mọi trường hợp cần phẫu thuật.

## 2. Chẩn đoán điều dưỡng

2.1. Người bệnh đau sau mổ

2.2.Nguy cơ chảy máu vết mổ

2.3. Người bệnh thiếu kiến thức về bệnh

## 3. Lập kế hoạch chăm sóc

Đặt mục tiêu cá thể và thời điểm đánh giá: hô hấp/tuần hoàn ổn định, triệu chứng giảm so với ban đầu, dung nạp ăn/uống phù hợp, không xuất hiện dấu nguy hiểm, người bệnh/người chăm sóc hiểu kế hoạch. Phân công người thực hiện và tần suất theo dõi theo nguy cơ/y lệnh.

3.1.Giảm đau cho người bệnh

3.2.Giảm nguy cơ chảy máu

3.3.Cung cấp kiến thức cho người bệnh

## 4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1.Giảm đau cho người bệnh:

- Thực hiện y lệnh thuốc  giảm đau cho người bệnh

4.2.Giảm nguy cơ chảy máu:

Quan sát lượng/màu máu, nuốt liên tục, hô hấp và sinh hiệu. Chảy máu đỏ tươi, kéo dài hoặc khó thở: báo bác sĩ ngay; cầm máu tại chỗ chỉ theo hướng dẫn đã được xác nhận, không để gạc rời trong miệng trẻ gây sặc.

4.3.Cung cấp kiến thức cho người bệnh

Thuốc, cho bú/ăn lại và tái khám theo chỉ định. Không tự kéo mở vết thương sau cắt thắng; phối hợp hỗ trợ bú. Chảy máu, bỏ bú, sặc hoặc khó thở cần khám ngay.

## 5. Đánh giá

-Người bệnh cải thiện

Đánh giá lại bú/ăn, đau, chảy máu và cân nặng; không bảo đảm hết bú sặc chỉ bằng cắt thắng.

- Bệnh hiểu biết về bệnh

Ghi kết quả theo từng mục tiêu, triệu chứng/sinh hiệu trước và sau, mức ăn uống và nhu cầu hỗ trợ; điều chỉnh kế hoạch khi chưa đạt hoặc có vấn đề mới. Không ghi chung “khỏe hơn” để thay giá trị theo dõi.

## Ghi chép bàn giao và hướng dẫn sau chăm sóc

Ghi nhận định, vấn đề, mục tiêu, thuốc/can thiệp, đáp ứng và thời điểm báo bác sĩ; bàn giao ISBAR, nơi và người tiếp nhận khi chuyển. Hướng dẫn đúng đơn, lịch tái khám cụ thể và dấu nguy hiểm; yêu cầu người chăm sóc nhắc lại. Không đợi hết thuốc khi có dấu xấu đi.

## Căn cứ và nội dung cần xác nhận

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . QĐ3023/QĐ-BYT dùng cho đề cương kỹ thuật khi có quy trình kỹ thuật riêng, không dùng để xác lập mọi can thiệp chăm sóc bệnh lý.

Nguồn chuyên môn tham khảo: https://www.healthychildren.org/English/news/Pages/AAP-report-addresses-rise-in-tongue-tie-diagnoses-for-breastfeeding-concerns.aspx. Áp dụng theo đối tượng và hoàn cảnh của hướng dẫn, không thay thế chỉ định bác sĩ hoặc quy định của bệnh viện.

Khoa TMH xác nhận chẩn đoán/mã ICD, danh mục kỹ thuật được phép, thuốc và kế hoạch theo dõi theo tuổi. Các chẩn đoán điều dưỡng trong nguồn là gợi ý, chỉ chọn khi có dữ liệu thực tế; không mặc định mọi người bệnh đều có tất cả vấn đề.

Người thẩm định/chữ ký/ngày: …… Số quyết định/ngày hiệu lực: ……